مساء الفل على الكل
على اساتذتي و زمايلي و صحابي

بعتذر عن التاخير في عمل البوست للرد على سؤال الدكتورة الزميلة العزيزة بخصوص التطعيمات بس انا مابقتش عارف اتكلم بتفاصيل و لا اتكلم اقول ايه ... هاسرق كلمة د معتز.... اقول شغل العلم و لا شغل السوق ..... فانا قررت اتكلم زي ما بكلم دكاترة امتياز لسه اول يوم امتياز النهاردة ... و هاقول كل التفاصيل العلمية (شغل العلم)

و بعدين هاعمل جدول الي انا شخصيا بشتغل بيه (طبيا سليم ... لكن غير ملزم و ممكن نعمل غيره و بردو يبقى سليم)

...ايه هي التطعيمات

بتشتغل ازاي

انواع التطعيمات

سمعنا ان لازم يبقى في فاصل زمني بين اي تطعيم و التاني

طب ايه التطعيمات الي اديها لابني او بنتي .. و هل في تطعيمات غير التطعيمات الاجبارية

ايه الصح و الغلط في التطعيمات ... ده الي هنشرحه دلوقتي

التطعيم هو جزء من ميكروب مثلا (surface antigen, part of capsule) او الميكروب كامل معالج طبيا بطريقة ما عشان لما يدخل الجسم (بالفم او الحقن حسب نوعه) يبتدي جهاز المناعة بتاعنا يكون ضد التطعيم ده اجسام مضادة (antibodies) و دي بتحمي جسمنا من المرض الاصلي او من مضاعفاته لو اتعرضنا ليه

بعض التطعيمات بتدي مناعة دائمة (يعني بتعمل اجسام مضادة تعيش في الجسم مدى الحياة) و بعض التطعيمات بتدي مناعة مؤقتة و يلزم تكرارها بصفة دورية

لكل تطعيم نظام خاص في اعطاء جرعاته يختلف عن غيره عشان نضمن افضل نسبة استجابة من الجسم للتطعيم لازم نلتزم بالنظام ... و مفيش تطعيم بيدي مناعة بنسبة 100% . لكن ممكن توصل نسبة الوقاية من المرض لغاية 96 % و دي نسبة كويسة جدا .. و حتى ال 4% الباقيين بيكون المرض عندهم اخف شوية لوجود نسبة من المناعة ناتجة عن التطعيم.

التطعيمات بتنقسم نوعين

تطعيم حي مضعف (live attenuated) و ده عبارة عن الميكروب كامل بس مضعفين قوته و مقللينها عشان ميعملش المرض و يشتغل مع جهاز المناعة بس و ده مثلا زي الجديري المائي و الثلاثي الفيروسي MMR و فيروس الروتا و فيروس شلل الاطفال الفموي

تطعيمات مقتولة (killed) اجزاء من الميكروب و دي بتبقى جزء من غلاف الميكروب او من البروتينات الخاصة بالميكروب الي بتقدر تشغل جهاز المناعة و تعمل اجسام مضادة زي مثلا كبدي_ب و الانفلونزا البكتيري ب و الانفلونزا الموسمية و الثلاثي البكتيري و الحمى_الشوكية (الميكروب السحائي) و المكورات الرئوية

طيب ازاي نقدر ندي التطعيمات.

الجسم يقدر يتعامل مع **اي عدد من التطعيمات اذا اتاخدت في نفس_الوقت** ...

بس لو حصل اننا اخدنا تطعيمات في اوقات مختلفة، استجابة الجسم ليها هتختلف من واحد للي بعده و هتقل بالتدريج .. عشان كده في شوية قواعد اغلب الاطباء بيشتغلوا بيها عشان يضمنوا افضل استجابة للجسم ضد التطعيمات المعطاه

القاعدة الاولى

الاتزام بنظام التطعيم الخاص بكل طعم و عدم استخدام بدائل مختلفة لنفس الميكروب

يعني مثلا عندي نوعين في السوق للميكروب السحائي و عمر الطفل يسمح ادي اي واحد من الاتنين ... هاختار احد فقط الي ادي بيه الكورس كامل

القاعدة الثانية

لازم فاصل زمني لا يقل عن 28 يوم (مجازا شهر) بين اي تطعيمين من النوع الحي المضعف live attenuated و الاستثناء الوحيد هنا بين فيروسي شلل الاطفال بالفم و فيروس الروتا بالفم .. كان زمان الفاصل 14 يوم و حاليا لا يوجد داعي للفصل بينهم عشان كل واحد فيهم بيشتغل على specific intestinal receptor

القاعدة التالتة

ان ممكن اعطاء اي عدد من التطعيمات الحية او المقتولة مع بعض و الجسم هيستجيب ليها كلها ... شرط انها تتاخد في اقل من 24 ساعة ... و شرك انها متكونش بتتفاعم مع بعض و تخلينا منستفادش منها (زي ميناكترا مع بريفانار... هنوضح كمان شوية)

القاعدة الرابعة

ان كل تطعيم له نظامه و مواعيده و في فاصل زمني لازم يمر بين اي جرعتين مختلفتين لنفس التطعيم لكن ده يسري على الجدول الاولي للتطعيم (يعني بيبي مولود و مشرف حضرتك في العيادة من اول يوم) لكن في نظام مختلف للتطعيمات للي فاتهم الجدول الاولي

و ده اسمه (catch up schedule) بنمشي بحاجة تانية اسمها minimum interval الي هي اقل فترة مسموحة بين جرعتين لنفس الطعم و ده بيبقى جدول تفصيل حسب الطفل الي قدامي عمره ايه و اخد ايه تطعيمات قبل كده

عشان كده بننصح الي يتطعم في مكان .. ياخد ورقة او يعمل جدول يعرف بيه اخد اي تطعيم امتى .. عشان لو حصل و غير المكان لظروف سفر او غيره .. يبقى عارف ايه التطعيمات الي اخدها اطفاله و فاضل لهم ايه يتطعموه

هاتكلم دلوقتي على التطعيمات الاضافية ... عشان هي دي الي بنديها للاطفال في عياداتنا
هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل
نبتدي بالروتا rota virus vaccine و ده live attenuated vaccine
مينفعش ادي تطعيم الروتا لمن عمرهم اقل من 6 اسابيع و هو بتاخد نقط بالفم ... و الفاصل الزمني للجدول الاولي هو شهرين و لازم اخلص جدول التطعيم قبل تمام 8 اشهر (مع العلم ان منظمة الصحة العالمية في 2018 مدت الفترة دي في الدول المنتشر فيها الفيروس لحد سن سنتين ... لكن لحد دلوقتي و بعد نقاش مرير مع ممثلي الشركات المنتجة في مصر لم يتم تعديل توصيات الشركات المنتجة مع الاقرار بصحة ما جاء في جدول منظمة الصحة العالمية .... ملناش دعوة يا محيي احنا مؤدبين و بنسمع كلام الشركات ... و الي هيدي بعد سن 8 اشهر ده يعتبر off label use و على مسؤولية الطبيب ... بس في اي حال لازم نتاكد ان مافيش حد من اقارب الدرجة الاولى و التانية حصل له تداخل امعاء قبل ما تدي التطعيم و دي هي ال contra indication الوحيدة

في منه نوعين

RV1 (monovalent human strain rotavirus)و اسمه التجاري Rotarix

و ده جرعتين اقدر ادي الجرعة الاولى من اول 6 اسابيع لحد 5 اشهر و الجرعة التانية بعدها بشهرين

RV5 (Pentavalet non human strains) و اسمه التجاري rotateq

و ده 3 جرعات اقدر ادي الجرعة الاولى من اول 6 اسابيع لحد 3 اشهر و بردو شهرين بين الاولى و التانية و بين التانيه و التالتة

تاني تطعيم هنتكلم عليه هو تطعيم المكورات الرئوية و ده killed vaccine هو اجزاء من الكبسول بتاع الباكتيريا و حسب عدد ال strains في كل تطعيم بياخد رقم
احنا هنتكلم عن ال pneumocoal conjugate vaccines ملناش دعوة بال non conjugate عشان ده مش في الجدول بصفة روتينية و مش بيتاخد قبل سنتين

بردو نوعين

PCV10 اسمه التجاري synflurix

و التاني PCV13 و اسمه التجاري Prevnar 13 (عشان كان زمان في بريفنار 7)

و الاتنين دول اقدر ادي اول جرعة من عمر 6 اسابيع و الجدول الاساسى ليه هو 3 جرعات اولية بفارق شهرين بين الجرعات و جرعة منشطة عند 12-18 شهر

و لو اول جرعة اتاخدت لطفل 7 اشهر او اكبر هيبقى الجدول جرعتين بينهم شهرين و منشطة من 15-18

التطعيم التالت

الميكروب السحائي (meningococcal conjugate vaccines) و ده رباعي . يعني يحتوي على 4 سلالات الي هي acwy

الي اشتغلت بيهم نوعين
مع اني اعرف ان في نوع تالت بس ما شوفتوش
النوعين هما
niminrix
و ده بيتاخد من اول شهرين و هو 3 جرعات بينهم شهرين فاصل

و لو بيبي اكبر من سنة في مدرسة بتقول جرعتين بينهم شهرين و في مدرسة بتقول جرعه واحدة

و النوع التاني

Menactra

و ده بيتاخد من اول 9 اشهر و جرعة تانية بعد الاولى ب 3 اشهر (و ده تجاريا منتشر اكتر من الاول)

و لو اكبر من سنة هو هو نفس الجدول

و النوعين بيتاخدوا جرعة واحدة بعد سن سنتين
و لا تكرر الا في الحالات التالية
وجود وباء للسحائي و مر 5 سنين على اخر جرعة
وجود امراض قد تؤثر على مناعة الطفل (immune compromised) و هنا هيكرر التطعيم كل 5 سنين

قبل دخول الكلية عند 16 او 17 سنة جرعة منشطة عشان الزحمة بتزود انتشار الميكروب

كده نبقى خلصنا الجزء الاول من التطعيمات
في الجزء التاني يوم الاحد او الاتنين ان شاء الله هنكمل
الجديري و الكبدي و الانفلونزا الفيروسي
و هاكتب الجدول الي انا شغال بيه
في انتظار اي اسئلة